

INFORME BROTE INTRAHOSPITALARIO SARS CoV2 Unidad de Geriatría

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
 E.U. Paulina Antonucci Sotomayor Encargada Programa Control de Infecciones	 E.U. Macarena Escobar Armijo S.S.M.C. Departamento de Calidad y Seguridad del Paciente	Ingrid Luengo Jara Directora (S) Hospital El Carmen Dr. Luis Valentín Ferrada
 E.U. Lilian Barja Muñoz Encargada Programa Control de Infecciones	 Dra. Yadira Pérez Paraqueimo. Médica Infectólogo Programa Control de Infecciones	
Marzo a abril 2025		

CONTENIDO

INTRODUCCIÓN	3
DESARROLLO	3
<i>Detección y diagnóstico de brote</i>	3
<i>Intervenciones realizadas</i>	4
<i>Fechas de Hitos:</i>	6
<i>Desenlace</i>	7
<i>Letalidad</i>	7
CONCLUSIONES	7

INTRODUCCIÓN

Dada la contagiosidad que demostró tener el virus SARS CoV2 tras la pandemia, distintos centros de atención, tanto públicos como privados, han presentado algún tipo de brote epidémico por este virus. El Hospital El Carmen “Dr. Luis Valentín Ferrada” no ha estado exento a esto, generándose contagios al interior del centro de salud, en este caso, en la Unidad de Geriatría entre los días **16 de marzo 2025 y 14 de abril 2025**, a través de nuestra vigilancia diaria donde se pesquiza la aparición de **brote paciente-funcionario**, por SARS CoV2. Este informe da a conocer el **agente, fecha de inicio y término, número de casos y expuestos, servicio afectado y curva epidémica, como así, su respectivo análisis de sus causas, intervenciones realizadas y evaluación de su impacto.**

DESARROLLO

Detección y diagnóstico de brote

El día **17 de marzo 2025** el Programa de Control de Infecciones (PCI) realiza revisión de resultados positivos para SARS CoV2 en plataforma de toma de muestra descargable desde MINSAL, donde se pesquisan un aumento de muestras positivas relacionadas al **Servicio de Geriatría** desde el **13 de marzo 2025**, tanto por PCR como test de antígeno, donde dichos pacientes contaban con más de 48 horas de hospitalización en misma unidad.

Tras este análisis, PCI detalla:

Caso índice

Paciente **sala 529a** positivo para SARS CoV2 tras toma de muestra **16-03-2025** e inicio de síntomas sugerentes para SARS CoV2 mismo día.

Caso primario:

Paciente **sala 528A** positivo para SARS CoV2 tras toma de muestra **13-03-2025** e inicio de síntomas respiratorios sugerentes en la misma fecha.

Casos secundarios

Los casos secundarios corresponden a la totalidad de pacientes que presentaron resultado positivo para SARS CoV2 con o sin sintomatología respiratoria sugerente con nexo epidemiológico con casos positivos del brote.

Dentro de estos, el día 02-04-2025 se detecta una funcionaria del servicio clínico de Geriatría, con cuadro respiratorio compatible para SARS Cov2, el cual por nexo se asocia al brote. Inicia síntomas el día 01-04-2025, realizándose la confirmación diagnóstica el día 02-04-2025 en la Unidad de Salud del trabajador (UST) del HEC. Este corresponde al último caso detectado, asociado al brote epidémico.

El mismo día de la detección, **17 de marzo 2025**, se notifica brote detectado en plataforma **SICARS**, se notifica a Unidad clínica y se formaliza mediante correo la notificación a **Subdirección de Gestión Asistencial (SDGA)** y Servicio de **Salud Metropolitano Central (SSMC)**.

- ✚ **Hipótesis:** Quiebre de medidas de prevención de COVID-19 como uso de EPP y lavado de manos, por parte de familiares, pacientes y funcionarios generaron propagación de agente a resto de pacientes y funcionarios de la unidad.
- ✚ **Definición de caso:** Paciente hospitalizado en servicio clínico Geriatría por más de 48 hrs, que ingresa por motivo distinto a infección por COVID-19, y que tiene resultado positivo para PCR o Test de antígeno.
- ✚ **Definición de expuestos:** Todo paciente hospitalizado en Servicio de Geriatría desde el 11-03-2025 hasta 14 días posterior a último caso positivo.

Intervenciones realizadas

Ante la ocurrencia de este brote, el Programa de Control de Infecciones realiza las siguientes intervenciones:

Medidas indicadas:

- ✚ Instalar precaución adicional de contacto y gotitas, a pacientes casos positivos y contactos, instalar señalética hospitalaria y letrero institucional.
- ✚ La realización de Test antígeno a la totalidad de los pacientes hospitalizados en la unidad implicada ya fue realizada el día de ayer (sector A y sector B). Esta indicación fue otorgada vía telefónica y el equipo de Enfermería de la Unidad de Geriatría ya realizó la toma de manera ágil y oportuna.
- ✚ Pacientes confirmados para SARS COV2 pueden realizar cohorte con otros pacientes positivos o COVID-19 recuperados.
- ✚ Todos los pacientes que se encuentren en la misma unidad con los casos positivos serán considerados **CONTACTOS ESTRECHOS** y deberán realizar cuarentena de 3 días contando como día 0 el día de separación de caso índice, **tomando PCR el 3er día de cuarentena**. Se levantará aislamiento una vez conocido el resultado de PCR, el cual **debe estar negativo**. Los contactos estrechos sólo pueden realizar cohorte siempre y cuando sean del mismo caso índice.

- ✚ Todo paciente que ingresa debe ser con **previa toma de test de antígeno realizada en unidad de origen, a su vez, todo paciente que es trasladado desde Geriatria a otras unidades** debe tener TR tomado con vigencia de máx 24 hrs.
- ✚ Se establece **USO OBLIGATORIO DE MASCARILLA** a toda persona que ingrese a la unidad, ya sea Personal clínico, administrativo, de unidades de apoyo, concesionaria, personal de alimentación, familiares, en todo momento y en todo lugar (atención directa de paciente y área administrativa).
- ✚ Se establece **USO OBLIGATORIO DE MASCARILLA QUIRURGICA** para los pacientes, siendo responsabilidad del personal CLINICO supervisar su uso correcto en los pacientes a cargo.
- ✚ Se mantiene el uso de los siguientes EPP ante la atención de pacientes COVID (+) Y contacto estrecho: mascarilla quirúrgica, pechera con mangas y guantes. En el caso de realizar PGA se indica el uso de mascarilla N95 (o equivalente) y antiparras o escudo facial.
- ✚ Evitar cambios de tutor en el caso de los pacientes que requieran acompañamiento continuo hasta completar cuarentena del paciente. En caso de que el tutor comience con sintomatología y/o se confirme el diagnostico con test positivo para COVID-19 (PCR-Test de antígeno), debe retirarse del hospital. En este caso, se debe realizar cambio de tutor.
- ✚ La jefatura del servicio clínico es responsable de realizar refuerzo y supervisión continua y permanente de cumplimiento de medidas de prevención COVID-19 al personal de la unidad.
- ✚ El uso de equipamiento clínico y médico debe ser de uso individual (Termómetros, mangos de presión, patos, chatas, etc.). De no contar con equipamiento para uso individual, debe realizarse limpieza y desinfección de insumos.
- ✚ La ropa de cama de todo paciente positivo y contacto estrecho debe ser embolsada en bolsa plástica transparente, rotulada, y diferenciada con la etiqueta "PAE" escrita en rótulo.
- ✚ En cuanto a **manejo de REAS** generado en unidades de pacientes COVID (+) y contactos estrechos, éste debe realizarse como residuos asimilables a domiciliarios (EPP en contenedor negro con bolsa negra), salvo los residuos catalogados como especiales.

RAD

- ✚ Actividad docente asistencial de pregrado deberá priorizarse en pacientes sin infección por SARS COV2. No deben atender a pacientes confirmados o contactos estrechos.

OIRS

- ✚ Visitas limitadas y restringidas en tiempo y cantidad mientras dure el brote.

Alimentación

- ✚ Los casos positivos y casos contactos estrechos, deberán recibir alimentación en utensilios desechable, el resto de los pacientes podrá recibir alimentación en utensilios reutilizables.

- ✦ Personal de alimentación puede ingresar a las unidades implicadas, pero no puede ingresar a las salas de pacientes positivos o contactos estrechos.

La curva epidémica se presenta en el siguiente gráfico:

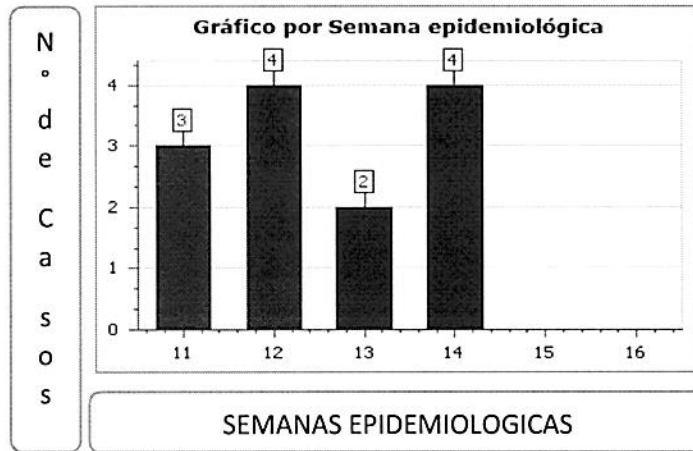


Figura N° 1: Curva epidémica según semana epidemiológica

Fechas de Hitos:

- ✦ Detección de brote: 17-03-2025
- ✦ Notificación a SSMC: 18-03-2025
- ✦ Caso índice: 16-03-2025
- ✦ Caso primario: 13-03-2025
- ✦ Inicio de brote (exposición): 11-03-2025
- ✦ Registro de brote en SICARS: 18-03-2025
- ✦ Validación de brote en SICARS: 18-03-2025
- ✦ Autorización de brote en SICARS: 18-03-2025
- ✦ Notificación y toma de conocimiento por SDGA: 18-03-2025
- ✦ Cierre de brote: 14-04-2025

Desenlace

El ultimo caso diagnosticado, del brote, para SARS CoV2 corresponden a una funcionaria de iniciales YRG, de 33 años, que inicia síntomas 01-04-2025, acude a la Unidad de salud del Trabajador el 02-04-2025, en donde se le realiza la toma de Test Rápido, resultando positivo para la infección antes mencionada. Expuesta en su unidad, en donde la hipótesis es que hubo algún quiebre de las medidas de prevención de IAAS. La Funcionaria no presenta neumonía asociada al cuadro infeccioso, por lo que termina su cuarentena en 5 días.

Letalidad

No se presentan fallecidos asociados al brote epidémico.

Tabla Cálculo de letalidad asociada a brote SARS CoV2 en Unidad de Geriatria.

Total Fallecidos	0
Total muertes auditadas	0
Total Casos	13
Muerte asociada (A+B*)	0
Letalidad Asociada	0%
Numero de Expuestos	217

**La infección intrahospitalaria contribuyó a la muerte sin ser causa de ella.*

CONCLUSIONES

Desde el inicio del brote al cierre de este, se presentaron un total de 13 casos, en donde se desarrolló la infección en 12 pacientes y una funcionaria. Se generaron 18 contactos estrechos (de estos, hubo 2 pacientes expuestos 2 veces, con 2 casos positivos distintos) y de estos, 2 contactos expuestos positivizados.

Posterior a último caso, no se presentaron nuevos casos de transmisión nosocomial por SARS CoV2 en Geriatria, por lo que el programa de intervención fue exitoso, lo que evidencia que todas las acciones realizadas causaron el impacto deseado asegurando una atención segura que logró disminuir el contagio de SARS CoV2 en nuestros usuarios hospitalizados y así igualmente lograr que ningún funcionario resultase positivo para SARS CoV2

El Programa de Control de Infecciones continúa reforzando medidas de prevención SARS CoV2 en la Unidad de Geriatria, como utilización correcta de EPP e higiene de manos tanto a funcionarios como

familiares al momento de la visita, a la totalidad del personal, tanto en su supervisión a través jefaturas directas, como en la revisión diaria por parte de este programa.

Cobra vital relevancia la comunicación activa entre la Unidad de Gestión de Pacientes, el equipo clínico del servicio y la jefatura de este, apoyando, supervisando y efectuando las medidas que el Programa Control de Infecciones indica ante la aparición de casos positivos y estudios de brote, como parte importante del control de este.

La colaboración activa por parte del equipo clínico de Geriatria, ante las medidas indicadas por el Programa de Control de Infecciones, permitió contener este brote, evitando mayor propagación de éste. La educación continua efectuada en temas de prevención de IAAS, y la constante supervisión liderada por la jefatura de la unidad, propició que el equipo de salud se mantuviera adherido a estas medidas.

Prevenir este tipo de brotes es crucial para mantener una atención hospitalaria eficiente, por lo que las acciones de la unidad clínica, del Programa de Control de Infecciones y de la Unidad de gestión de Pacientes, debe ir enfocada a detectar y evitar nuevos quiebres en las normativas de IAAS que puedan propiciar la aparición de brotes epidémicos, que conllevan a un mayor uso de recursos como, mayor estancia hospitalaria, aumento de uso de EPP, al tener que establecer aislamientos, cohortes se deben realizar bloqueos de camas y condicionamientos de camas y tomas de muestras adicionales para contenerlos. Esto aumenta los costos monetarios en cuanto a la estancia d ellos pacientes en esta institución.

Así también, se evidencia la importancia de mantener y cumplir los procesos establecidos como el reporte de precauciones adicionales generado por las unidades, que es informado a Programa de Control de infecciones y a sociedad concesionaria, quienes son encargados de realizar los aseos de superficies que evitarán la propagación ambiental de microorganismos de importancia epidemiológica.